SDD 251 Sujet n°1

Spécialité : Médecine interne

Date : 23/12/2024
Auteurs : Clémence BOSC (DES psychiatrie, EN 2024), Alexandre LANNOY (DES neurologie, EN 2024), Camille MARTINAUD (DES psychiatrie, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EN 2024)

Domaine d'apprentissage principal	Education thérapeutique
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	Item 330 - Prescription médicamenteuse des classes courantes
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 251 - Prescription de corticoïdes par voie locale et générale
Matériel nécessaire à la station	
Contexte de la station	Initiation de traitement à l'hôpital

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes rhumatologue à l'hôpital, et vous recevez Mme N., 71 ans. Cette patiente présente des douleurs inflammatoires des épaules et des hanches. Une pseudopolyarthrite rhizomélique a alors été diagnostiquée.

Vous souhaitez initier un traitement au long cours par corticothérapie per os.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Expliquer les modalités de prise de traitement, en évoquant notamment les effets indésirables possibles
- Proposer les mesures préventives et/ou thérapeutiques appropriés en fonction du contexte

Vous ne devez pas :

- Prescrire d'examens complémentaires
- Planifier le suivi

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patiente standardisée (PS).

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
1.	Explique qu'il ne faut **jamais arrêter le traitement par corticothérapie brutalement**.	1 pt
2.	Explique que la **décroissance** de la corticothérapie se fait de manière **progressive**.	1 pt
3.	Evoque le risque **d'infections**.	1 pt
4.	Explique qu'il faut **consulter rapidement un médecin en cas de fièvre**.	1 pt
5.	Evoque les autres **effets indésirables** possibles : - hypertension artérielle - intolérance au glucose/diabète cortico-induit - obésité/prise de poids - dyslipidémie - ostéoporose - troubles du sommeil *(au moins 4 éléments sur 6 pour avoir le point)*	1 pt
6.	Evoque les **principales règles hygiéno-diététiques** : - activité physique régulière - limitation des apports sodés - limitation des apports en sucres rapides - régime enrichi en calcium - régime enrichi en protides *(au moins 3 éléments sur 5 pour avoir le point)*	1 pt
7.	Propose un traitement par **inhibiteurs de la pompe à protons ou protecteur gastrique**.	1 pt
8.	Propose un déparasitage à **l'ivermectine**.	1 pt
9.	Propose une **vaccination contre la grippe <u>et</u> le pneumocoque**.	1 pt
10.	Propose un **traitement anti-ostéoporotique** (biphosphonate ou tériparatide).	1 pt
11.	Propose un traitement **antalgique**.	1 pt
Communications et attitudes		

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	**16 points**

Corticothérapie
Les contre-indications sont relatives : Infections récentes ou patentes (groupe herpès, tuberculose…) Allaitement : ok si < 30 minutes et > 4 heures d'écart
Si prolongé : - Poids, IMC, PA, recherche de foyer infectieux - NFS, EAL et GAJ, ionogramme et bilan phosphocalcique - ECG, RTX, ostéodensitométrie si > 3 mois - EPS si séjour récent ou patient originaire d'une région tropicale
- Local
- Rétention HS, intolérance au glucose, obésité -fascio-tronculaire), hyperlipidémie - Ostéoporose CTC induite, myopathie des ceintures, rupture tendineuses, cutané (atrophie, hypertrichose et hyperplasie sébacée, acné et eczéma, gale dermatophite et herpès) (**tardif**) - Retard staturo-pondéral de l'enfant, aménorrhée et impuissance - Neuropsychique (insomnie, exaltation : **précoce**), oculaire (glaucome, cataracte sous-capsulaire postérieur) - Dyspepsie, ulcère, infection (**précoce**)

- Arrêt : insuffisance surrénalienne, fatigue, faiblesse (**si prolongé**)
Tout traitement anti-infectieux
1) Alimentation : moins de sel et de sucres rapides, plus de protéines et calcium 2) **Sport** 3) Traitements associés : * ivermectine si séjour dans zone à risque * vaccination grippe et pneumocoque * calcium/vitamine D si carence * traitement anti-ostéoporotique (> 3 mois + > 7,5 mg/j, > 70 ans, T<-2.5, ATCD fracture faible cinétique) 4) **Pas d'arrêt brutal, consulter si fièvre ou douleurs abdominales**
Cardiovasculaire et infectieux : - PA, poids, suivi ophtalmologique - K 1-2 mois, glycémie régulière et EAL à 6 mois - 24 OHD2 et D3 - ODM à 1 an en l'absence de traitement anti-ostéoporotique

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes rhumatologue à l'hôpital, et vous recevez Mme N., 71 ans. Cette patiente a présenté des douleurs inflammatoires des épaules et des hanches. Une pseudopolyarthrite rhizomélique a alors été diagnostiquée.

Vous souhaitez initier un traitement au long cours par corticothérapie per os.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Expliquer les modalités de prise de traitement, en évoquant notamment les effets indésirables possibles
- Proposer les mesures préventives et/ou thérapeutiques appropriés en fonction du contexte

Vous ne devez pas :

- Prescrire d'examens complémentaires
- Planifier le suivi

Plan de la station ECOS :

Patient et médecin face à face séparé par une table

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

"Bonjour docteur, alors pour ma maladie vous me prescrivez des corticoïdes, c'est bien ça ?"

Identité du patient :

Mme N., 71 ans

Mode de vie :

Profession/étude, loisirs, statut marital, présence d'enfants, environnement (tout ce qui est nécessaire à la situation), tabac, alcool, allergies…

Retraitée, ancienne avocate
Célibtaire, pas d'enfants
Est rentrée d'un voyage au Sénégal il y a 2 mois
Pas de tabac, alcool, drogues
Pas d'allergie

Comportement global :

Ouverte, veut bien faire les choses.

Antécédents personnels :

- Hypertension artérielle
- Arthrose des genoux

Antécédents familiaux :

Pas connus.

Médicaments :

- AMLODIPINE 5 mg matin et soir
- KETOPROFENE 150 mg matin et soir en cas de douleur du genou
- Dernière vaccination : **DTP il y a 6 ans**

Symptômes positifs :

douleurs inflammatoires des épaules et des hanches, réveillant la nuit.
EN 4/10. Soulagées par kétoprofène.
Pas d'autre symptôme.